

养老机构服务规范（验收用）

声明：本文档为 RAG_Agent 功能验收专用虚构语料，数字与条款仅供检索/忠实问答测试，不代表任何真实国家标准或地方政策。现行版本：v3.2

生效日期：2024-06-01

废止说明：自生效日起，附录 A 所列 v2.0（2020）条款全部废止；遇新旧表述冲突时，一律以 v3.2 正文为准。

1. 总则

1.1 适用范围

本规范适用于经备案或许可的养老机构（含护理型、混合型），用于规范日常照护、感染防控、膳食、应急与记录管理。本标准（上述事项另文规定或未纳入本版）。

1.2 基本原则

机构应以安全、尊严、连续照护为原则；涉及老年人隐私的信息仅限工作必要范围查阅与交接。

2. 人员配备与补贴

2.1 护理人员配比（现行 v3.2）

- 护理型床位：护理员与入住老年人配比不低于 1:4（按实际在岗护理员计）。
- 混合型床位（自理+半失能为主）：配比不低于 1:8。
- 夜班时段（22:00-06:00）：每层楼至少安排 1 名在岗护理员；超过 40 张床位的楼层应增配 1 名巡回护理员。
- 配比核算周期为自然月；连续两月不达标须向机构负责人书面报告并制定补员计划。

2.2 护理员岗位补贴（现行 v3.2）

- 护理员岗位补贴：每人每月 800 元（税前，随工资发放）。
- 夜班津贴（与岗位补贴分列，不得互相冲抵）：每有效夜班 60 元；同一自然月累计夜班津贴上限 1200 元。
- 补贴与津贴须在工资条中分项列示；请假超过当月应出勤天数一半者，岗位补贴按实际出勤天数折算。

2.3 易混淆说明

岗位补贴（800 元/月）不等于夜班津贴（60 元/班）。问询「补贴标准」时，默认指 2.2 护理员岗位补贴；若问「夜班怎么补」

3. 基础护理要求

3.1 口腔护理

- 不能自理口腔清洁的老年人：口腔护理每日不少于 2 次（建议晨起与睡前各 1 次）。
- 口腔护理应记录执行时间与异常（溃疡、出血、义齿松动等）；连续 3 日未执行须在交接班中特别说明原因。

3.2 压疮（压力性损伤）预防与护理

- 不能自主翻身的卧床老年人：协助翻身间隔不超过 2 小时。
- 已出现 I 期及以上压疮：须建立专项护理记录，每日评估创面；翻身间隔可按医嘱缩短，但不得长于 2 小时。
- 压疮护理要求包括：减压、保持皮肤清洁干燥、营养支持评估、必要时请医护会诊；禁止擅自使用未经批准的外用药。

3.3 防范老年人跌倒

- 卫生间、浴室须配备扶手与防滑措施；夜间走廊保持基本照明。
- 高跌倒风险老年人外出或如厕时应有人陪同或呼叫响应；呼叫铃响应时间目标为 3 分钟内到达床边或呼叫点。
- 发生跌倒须在 30 分钟内完成初步处置与家属告知，并在 24 小时内完成书面事件记录。

3.4 给药管理

- 给药须严格执行「三查七对」；口服药应看服到口（不能配合者按医嘱与护理计划执行）。
- 自备药品须登记品名、剂量、有效期；过期药品立即隔离并通知家属。
- 发现错服、漏服：立即报告值班护士/负责人，并按应急流程处置，不得隐瞒。

4. 感染防控

4.1 基本要求

1. 工作人员上岗前完成手卫生；接触体液后立即洗手或手消毒。
2. 公共活动区每日清洁不少于 2 次；传染病流行期间按机构应急预案提高频次。
3. 隔离观察室与普通区动线分开；隔离期间探视按机构临时规定执行。
4. 体温异常（ $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ）老年人须登记并报告值班医护，必要时转运就医。
5. 可重复使用护理用具按消毒规范执行，并保留消毒记录至少 90 天。

4.2 环境与卫生清洁

- 居室开窗通风每日累计不少于 30 分钟（天气极端时改为机械通风）。
- 垃圾分类清运；感染性废物按医疗废物相关要求处理（委托有资质单位）。

5. 膳食服务

5.1 膳食规范要点

- 提供营养均衡的三餐；特殊饮食（糖尿病餐、低盐餐、糊状/细碎餐）须有医嘱或营养评估依据。
- 食品留样：每餐每品种留样不少于 125 克，冷藏保存 48 小时。
- 进食需协助者应有专人看护，预防噎食；发现噎食按急救流程处置并立即呼救。
- 食堂从业人员持有效健康证明上岗；生熟分开、餐具消毒可追溯。

5.2 与护理协同

膳食变更（如改为鼻饲或完全糊状餐）须同步更新护理计划，并在交接班中告知下一班。

6. 入住评估、康复与约束

6.1 入住评估关注方面

入住评估一般关注：日常生活活动能力、认知状态、营养风险、跌倒风险、压疮风险、慢性病与用药情况、精神行为症状、社会支持。

6.2 康复服务要求

- 康复以维持或改善功能为目标，须有评估与阶段性目标。
- 康复训练频次与强度由康复专业人员或在其指导下制定；护理员配合安全转移与日常功能活动。
- 疼痛、急性感染、不稳定生命体征期间暂停训练，并记录原因。

6.3 约束带使用限制

- 约束仅为保护老年人安全的最后手段，须有书面评估与知情同意（紧急情况可先行保护性约束，事后补办手续）。
- 约束期间至少每 30 分钟巡视一次；连续约束超过 2 小时须重新评估是否可解除。
- 禁止以约束代替照护人力不足；禁止惩罚性约束。

7. 应急处置与消防安全

7.1 突发不适应急

老年人突发胸痛、呼吸困难、意识改变、严重外伤或不典型急症时：

1. 立即呼救并通知值班医护/120（按机构流程）；
2. 保持呼吸道通畅，记录发病时间与生命体征；
3. 15 分钟内完成家属首次告知（无法接通则记录尝试次数与时间）；
4. 转运或就地抢救过程材料纳入病历/护理记录。

7.2 消防与安全管理制度要点

- 疏散通道保持畅通，安全出口指示与应急照明完好。
- 每月至少组织 1 次消防巡查；每半年至少组织 1 次全员疏散演练并留档。
- 禁止在居室使用明火及违规大功率电器；发现隐患 当日整改或升级上报。
- 值班人员须掌握灭火器位置与初期火灾处置步骤。

8. 隐私保护与护理记录

8.1 隐私保护

- 护理、洗澡、如厕等场景注意遮挡；非工作需要不得围观或拍摄。
- 病历、评估与影像资料不得擅自外传；对外提供信息须符合法定或家属授权程序。
- 讨论病情避开公共场合无关人员。

8.2 护理记录应包含的内容

护理记录至少包括：日期时间、执行人、生命体征或观察要点、护理措施、老年人反应与异常、交接事项。压疮、跌倒、约束。

8.3 交接班关键信息

序号 | 交接项 | 说明

- 1 | 在院人数与出入情况 | 含请假外出、新入住、出院
 - 2 | 重点关注老年人 | 高风险、新发不适、情绪异常
 - 3 | 未完成医嘱/护理任务 | 含原因与跟进责任人
 - 4 | 皮肤与压疮动态 | 新发或进展
 - 5 | 跌倒及其他不良事件 | 处置进展
 - 6 | 膳食与饮水特殊要求 | 含禁食、鼻饲变更
 - 7 | 物资与钥匙、呼叫设备状态 | 故障须登记报修
- 口头交接与书面交接一致；接班人确认后方可离岗。

9. 家属沟通

- 常规情况：照护计划重大变更应在变更前或变更当日与家属沟通。
- 异常情况：跌倒、走失未遂、突发不适、约束启用等，按本规范对应时限告知。
- 沟通应客观记录时间、对象、内容要点；争议事项提交机构负责人协调。

10. 本版明确未纳入事项

下列事项在本规范 v3.2 正文与附录均未给出标准，答复时应说明「本规范未规定」，不得编造数字：

- 异地旅居养老补贴金额或发放条件；
- 宠物陪护收费标准；
- 员工子女入学补助；
- 机构对外营销提成比例。

附录 A：已废止条款摘要（v2.0 / 2020，仅供对照，不得作为现行依据）

警告：以下为历史版本摘要，已于 2024-06-01 废止。

项目 | v2.0（已废止） | v3.2（现行）

护理员岗位补贴 | 每人每月 500 元 | 每人每月 800 元

护理型配比 | 不低于 1:5 | 不低于 1:4

口腔护理频次（不能自理） | 每日不少于 1 次 | 每日不少于 2 次

卧床翻身间隔 | 不超过 3 小时 | 不超过 2 小时

查询「2020 年旧版」数字时，应明确告知其为废止条款，并同时给出现行 v3.2 标准；不得只报旧数当作现行有效。

附录 B：版本与修订记录

版本 | 日期 | 说明

v2.0 | 2020-03-01 | 初版（已废止）

v3.2 | 2024-06-01 | 上调补贴与配比要求；缩短翻身与口腔护理相关间隔/频次；细化交接班与应急时限
文档结束。